

5. иммунологический.
6. генетический.
7. биофизический.
8. микологический.
9. иммуно-флюоресцентный.
10. радиоиммунный.

Региональные структуры как координаторы в реализации программы комплексной профилактики рака

Комплексная первичная и вторичная профилактика рака может быть осуществлена с помощью специальных подразделений, координирующих все перечисленные выше формы предупреждения злокачественных новообразований. Главным координатором реализации этих мероприятий может быть Департамент по лечебно-профилактической работе, аккредитации и анализа Министерства здравоохранения РК, который может проконтролировать осуществление каждого этапа санитарно-гигиенического, организационного, общего лечебного и онкологического звеньев в РК в целом и в ее регионах. Вероятно,

будет целесообразным организовать 5 межрегиональных центров по первичной и вторичной профилактике рака на западе, юге, севере, востоке и в центре Республики, в структуру которых будут входить отделы по комплексной профилактике рака. Каждый такой межрегиональный центр должен включать локальные самостоятельные отделения профилактики рака, осуществляющих всю работу на уровне населения областных, городских и районных акиматов.

Таким образом, изложенные сведения свидетельствуют о реальном их осуществлении, с одной стороны, и возможности существенного влияния комплексных профилактических мероприятий на имеющуюся в РК онкологическую ситуацию, с другой. Предлагаемые комплексные материалы в значительной мере согласуются с перспективным Планом мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан годы и соответствующими директивами Министерства здравоохранения РК (приказ № 14 от 11.01.05 и приказ № 114 от 15.03.05), которые указывают на необходимость научно-методического обеспечения и мониторинга ежегодных профилактических осмотров, диспансеризации и оздоровления населения.

Заболеваемость раком прямой кишки населения Республики Казахстан за 2000-2009 годы

*Кузикеев М.А., Сейтказина Г.Д.
Казахский НИИ онкологии и радиологии
УДК: 616.351-006.6 -036.22 (574)*

Актуальность

За последние десятилетия значительно увеличилась заболеваемость раком прямой кишки и авторы связывают это с некоторыми факторами, такими как изменением питания людей, большим количеством канцерогенов, увеличением продолжительности жизни.

Большинство авторов определяет его как умеренно- или малоподвижную опухоль, ограниченную мезоректомой или выходящую за пределы фасции прямой кишки, с прорастанием в соседние органы или отсутствие отдаленных метастазов. Высокая частота рецидивирования этой формы опухоли (26-37%) и низкая 5-летняя выживаемость (38-52%) характерны для данной локализации (Александров В.Б., 2001; Кныш В.И., 1997).

Рак прямой кишки занимает 6-е место в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в России. При этом местнораспространенный рак прямой кишки составляет до 20-30% (Чиссов В.И. и соавт., 2006).

Онкологическая статистика является основой как организации и проведения противораковой борьбы, так и научных исследований в онкологии. Частота злокачественных новообразований по отдельным нозологическим формам не осталась величиной постоянной. Кроме того существуют значительные различия в числе случаев заболеваний раком прямой кишки между мужчинами и женщинами, городских и сельских жителей.

Знание всех этих особенностей позволяет не только рационально проводить нынешние мероприятия противораковой борьбы, но и с учетом изменяющейся (в сторону постарения населения) демографической ситуации.

Настоящая статья посвящена анализу структуры и временных особенностей распространения рака прямой кишки среди населения Республики Казахстан за период 2000-2009 гг.

Цель исследования

– изучить особенности заболеваемости раком прямой кишки населения Республика Казахстан.

Материал и методы исследования

Исследование ретроспективное за 2000-2009 гг. Использованы данные показателей онкологической службы РК (Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др., 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

За этот период исследования в республике зарегистрировано 11098 больных раком прямой кишки, что составляет в структуре злокачественных опухолей – 4,0%.

Анализ среднегодовых интенсивных показателей заболеваемости рака прямой кишки в республике в возрастных группах в динамике за изучаемый период показал, что данные показатели имели тенденцию к росту. Так, среди лиц 0-29 лет данные показатели, как у мужчин, так и у женщин (0,1%000) занимали одинаковые позиции. В возрастных группах 30-39 лет аналогичные показатели варьировались с 1,4%000 до 1,8%000. В возрастных группах 40-49 лет идет рост данных показателей, среди мужского населения они были ниже (4,8%000) по сравнению с показателями среди женщин (5,3%000) и оба пола (5,1%000). Показатели заболеваемости рака прямой кишки среди лиц 50-59 лет варьировались с 15,2%000 до 17,5%000. Заметный рост заболеваемости данной локализации в республике зарегистрирован среди лиц 60-69 лет. У мужского населения - 50,4%000, среди женщин – 32,1%000 (рис.1)

Высокая заболеваемость рака прямой кишки наблюдается среди лиц в возрастных группах 70 лет и старше - 55,5%000 данный показатель среди мужского населения составил 82,1%000, а у женщин 43,0%000.

Повозрастные показатели заболеваемости рака прямой кишки мужского и женского населения республики за период

исследования выросли с увеличением возраста населения. Пик заболеваемости у всего населения в возрастных группах 70 лет и старше, с унимодальным характером роста.

Интенсивные показатели заболеваемости рака прямой кишки населения республики за 10 лет свидетельствуют о том, что в динамике эти показатели имели тенденцию колебания с 7,0‰ (2000г.) до 8,0‰ в 2003 году, в конце исследования данный показатель составил 7,2‰ (рис.2).

Динамика интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости рака прямой кишки мужского населения за изучаемый период имеет тенденцию роста. Период исследования завершился со значением показателя 7,6‰ (рис.3).

Темпы интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости совпадают.

Среди женского населения за 10-летний период отмечается рост показателей с 6,9‰ (2000г.) до 8,0‰ в 2005 году, начиная с 2006 года отмечается снижение до 6,7‰ в конце исследуемого периода (рис.4).

Высокие показатели удельного веса рака прямой кишки всего населения республики (рис.5) по возрастным группам имели неоднородный характер роста. Пик отмечается в возрастных группах 70 лет и старше у женского населения (35,4%), тогда как у мужчин удельный вес в данной возрастной группе составляет 33,4%. Показатель удельного веса в возрастной группе 60-69 лет у мужчин был выше (34,3%) по сравнению с показателем среди лиц 70 лет и старше (33,4%).

Общий среднегодовой интенсивный показатель заболеваемости рака прямой кишки по республике составил $7,3 \pm 0,1$ ‰, стандартизованный (мировой) – $7,3 \pm 0,1$ ‰. Повозрастные показатели заболеваемости рака прямой кишки мужского и женского населения республики за период исследования выросли с увеличением возраста населения. Пик заболеваемости у всего населения в возрастных группах 70 лет и старше, с унимодальным характером роста.

Таким образом, за 10-летний период исследования в республике доля рака прямой кишки в структуре злокачественных опухолей составляет – 4,0 %. Показатели заболеваемости рака прямой кишки за указанный период исследования были в пределах с 7,0‰ (2000г.) до 7,2‰ в конце периода.

Лидирующая позиция заболеваемости рака прямой кишки установлена в г. Алматы (12,4‰). Ряд высоких показателей отмечены в Павлодарской (12,2‰), Костанайской (12,1‰), Северо-Казахстанской (11,6‰) областях.

Наиболее низкими показателями заболеваемости рака прямой кишки отметились Южно-Казахстанская (2,7‰), Кызылординская (2,8‰), Жамбылская (3,2‰) и ряд областей западного региона республики (рис.6).

Изучение динамики заболеваемости рака прямой кишки

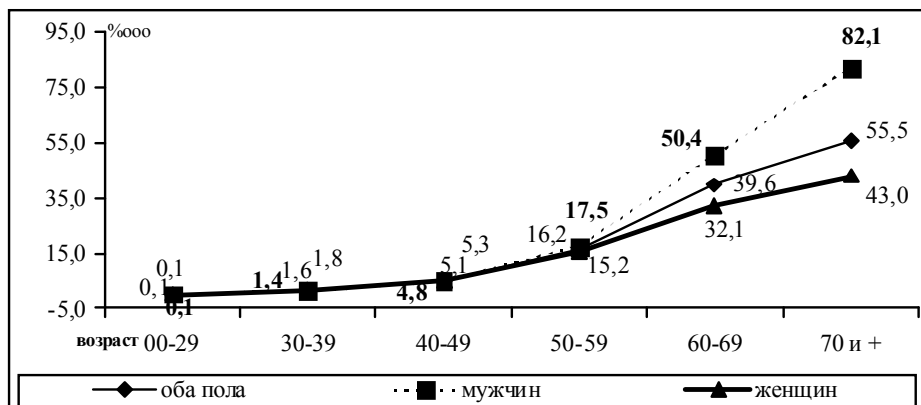


Рисунок 1 - Среднегодовые половозрастные интенсивные показатели заболеваемости рака прямой кишки населения Республики Казахстан за 2000-2009 гг.

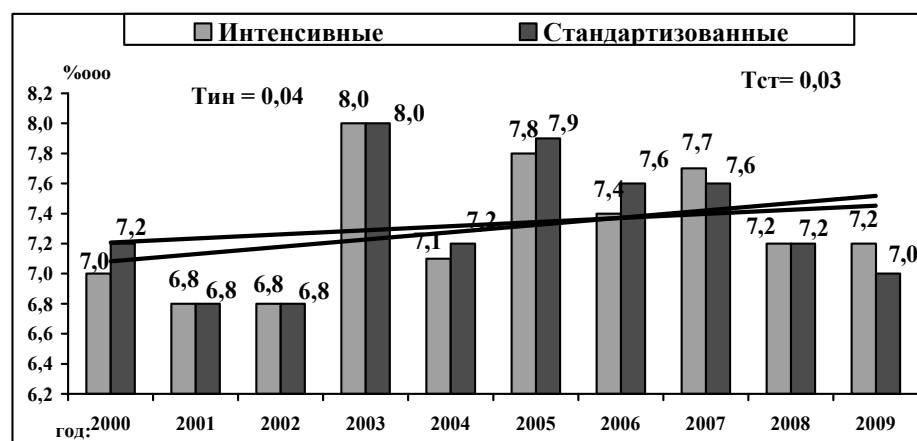


Рисунок 2 - Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости рака прямой кишки населения Республики Казахстан за 2000-2009гг.

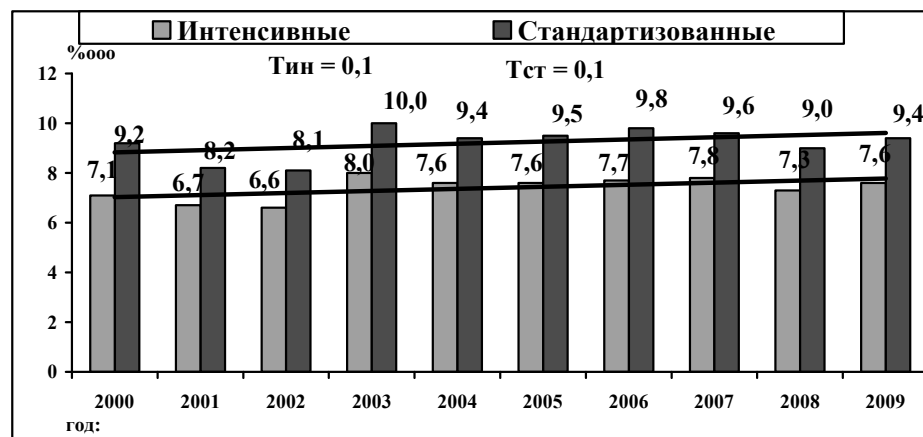


Рисунок 3 - Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости рака прямой кишки мужского населения Республики Казахстан за 2000-2009гг.

отдельно мужского и женского населения проведено в десятилетних временных и возрастных интервалах.

Возрастные особенности распространения рака прямой кишки в республике характеризуются тем, что в динамике уровень заболеваемости имеет тенденцию к росту в возрастных группах 70 лет и старше, и носит унимодальный характер роста.

Возраст является одним из основных факторов, с которым наиболее отчетливо связано развитие заболевания. Причем зависимость уровня заболеваемости от возраста более выражена по сравнению с другими факторами. Касается это и структуры заболеваемости в различных возрастных группах. Интенсивность роста заболеваемости с возрастом хорошо характеризует индекс отношения возрастного пика заболеваемости к уровню заболеваемости в возрасте 70 лет и старше.

Для адекватного сравнения уровней заболеваемости между поло-возрастными группами, как правило, используются стандартизованные показатели, исключающие влияние на их значения возможных различий в возрастном составе сравниваемых групп населения.

Чрезвычайно важным является изучение распространения заболеваемости во времени. Сопоставление максимального и минимального показателей заболеваемости раком прямой кишки в регионах республики позволяет заключить, что географические, региональные особенности в уровнях заболеваемости могут быть обусловлены различиями в составе населения сравниваемых регионов.

Более углубленные эпидемиологические исследования показывают, что изучение изменений в частоте, структуре и особенностях распространения рака прямой кишки на отдельных территориях республики дает необходимую информацию для планирования лечебно-профилактических мероприятий на государственном и региональном уровнях, способствуя совершенствованию онкологической помощи больным злокачественными новообразованиями прямой кишки.

Таким образом, анализ заболеваемости с учетом возрастного-половых особенностей населения республики за 10 лет (2000-2009гг.) показал, что в динамике рост заболеваемости зависит от возрастного состава населения, т.е. чем старше возраст, тем более пропорционально растет частота рака прямой кишки.

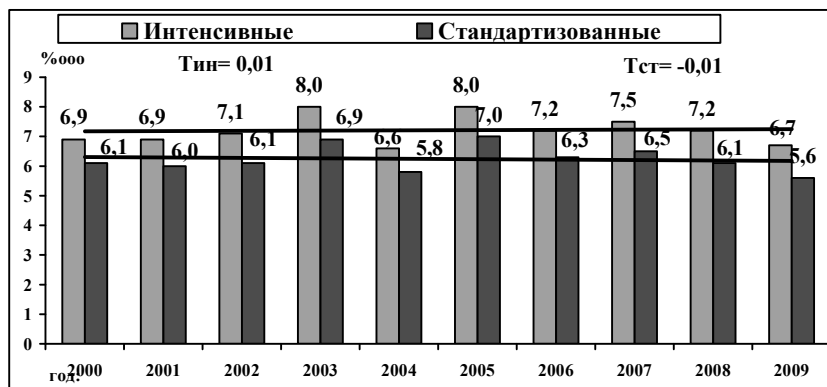


Рисунок 4– Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости рака прямой кишки женского населения Республики Казахстан за 2000-2009гг.

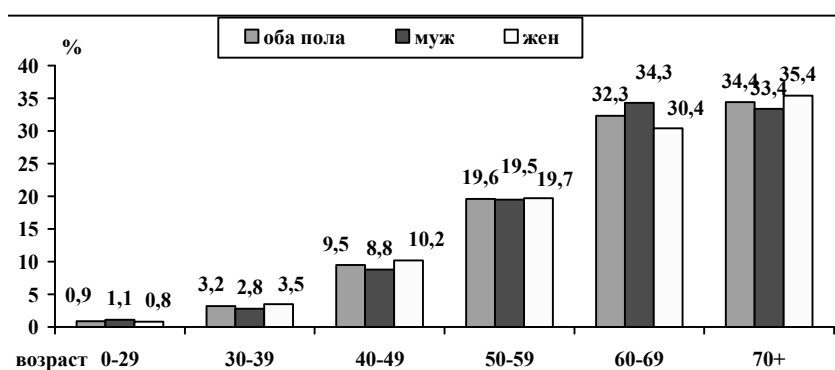


Рисунок 5 – Удельный вес рака прямой кишки по возрастным группам населения Республики Казахстан за 2000-2009гг.

Список использованной

литературы

1. Чиссов В.И., Старинский В.В. *Состояние онкологической помощи населению Российской Федерации.* -М., 2006.
2. Александров В.Б. *Рак прямой кишки.* -М., 2001.
3. Кыш В.И. *Рак ободочной и прямой кишки.* -М., 1997.
4. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др. *Показатели онкологической службы Республики Казахстан (статистические материалы).* -Алматы, 2002.
5. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др. *Показатели онкологической службы Республики Казахстан (статистические материалы).* -Алматы, 2003 – 2010.

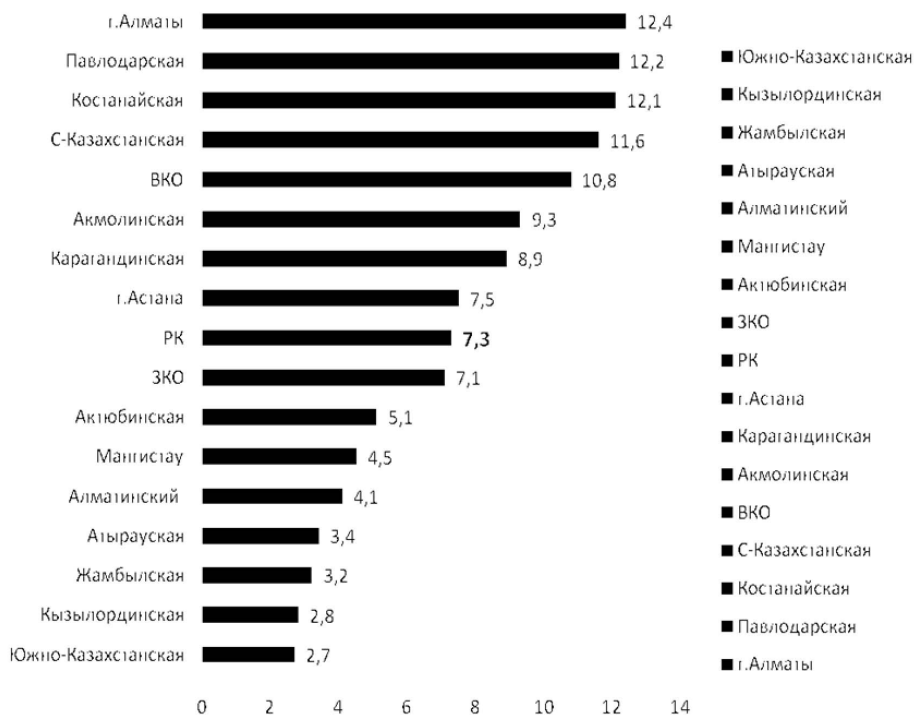


Рисунок 6 - Среднегодовые показатели заболеваемости раком прямой кишки по областям Республики Казахстан за 2000-2009 гг.